

Datos Personales							
Nombre:	JOSE LUIS ZAMBRANO RINCON	Sexo Biológ.:	H	F. Nacimiento:	2004-11-20	Edad	20 Años, 8 Meses, Y 13 Días
Identificación:	CC - 1067593365	Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	Soltero	Ocupación:	ESTUDIANTE
Correo Electrónico:	Zambranorinconjose@gmail.Com - 1067593365			Dirección:	Mz 7 Casa 13 Urb La Sabana		
Departamento:	CESAR		Municipio:	VALLEDUPAR		Zona:	Urbana
Empresa:	Particular						
En Caso De Emergencia Llamar A:		CLAUDIA RINCON - Parentesco (madre) - Teléfono (3164142768)					

Apertura psicología del 2025-08-03 11:33:47: 20 años, 8 meses, y 13 días

DATOS GENERALES

Remisión

Particular

Código de consulta

890208 - CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PSICOLOGIA

Motivo de Consulta

Acude a cunsulta y refiere "Me siento perdido, no me siento preparado para el semestre " "me frustro mucho, no se como manejar las situaciones cuando no se resolver algo" "no me provoca salir, me siento con mucha pesadez solo quiero dormir".

Enfermedad Actual

El paciente acude a consulta presentando sintomatología caracterizada por episodios recurrentes de llanto, estado de ánimo depresivo, sentimientos de desesperanza y temor persistente ante la posibilidad de no culminar sus estudios universitarios. Se observa anhedonia, disminución del apetito, desmotivación frente a las actividades de la vida diaria y frustración constante en su proceso de aprendizaje. Asimismo, se identifica un patrón de autoexigencia elevado con rasgos de perfeccionismo, lo cual parece acentuar la percepción de incapacidad y el malestar emocional.

Refiere que la sintomatología ha estado presente durante aproximadamente ocho meses, con un curso progresivo y una agudización significativa en los últimos tres meses. Como parte de este cuadro, el paciente ha dejado de practicar deporte, una actividad que anteriormente disfrutaba intensamente y que formaba parte de su rutina habitual. También ha iniciado un proceso de aislamiento social, limitando el contacto con sus pares y reduciendo su participación en contextos académicos y recreativos.

Como desencadenantes significativos, se identifica el proceso de separación entre la madre y el padrastro, lo cual ha generado conflictos familiares, llanto y discusiones frecuentes en el hogar. Esta situación ha reactivado emociones relacionadas con el divorcio anterior de los padres biológicos, considerado por el paciente como una experiencia traumática. La dinámica actual en casa se caracteriza por dificultades en la comunicación asertiva, presencia de gritos y tensión emocional, lo cual ha contribuido a su desmotivación generalizada y mayor tendencia al retraimiento.

ANTECEDENTES

Médicos Personales

Quirúrgico

Circuncisión

Tóxicos

No Refiere

Traumáticos

Ninguno

Medicación

Melatonina 3 Mg

Paraclínicos

Ecografías

Hospitalizaciones

Si

Patología

No Feriere

ANTECEDENTES

Médicos Familiares

Depresión

Madre

Ansiedad

Madre

Demencia

No Refiere

Alcoholismo

No Refiere

Drogadicción

No Refiere

Discapacidad Intelectual

No Refiere

Patológicos

Hipertensión

Otros

No Refiere

Áreas de Ajuste y/o Desempeño

Historia educativa

El paciente es bachiller y actualmente cursa sexto semestre del programa de Ingeniería Civil en una universidad de la ciudad de Santa Marta. Refiere haber mantenido un desempeño académico adecuado y buenas relaciones interpersonales con sus compañeros, destacando la conformación de un grupo de trabajo estable. Sin embargo, en el contexto del episodio depresivo actual, ha presentado conductas de aislamiento social, disminuyendo su participación en actividades grupales y reduciendo el contacto con su círculo académico cercano.

Historia laboral

No refiere

Historia familiar

El paciente convive actualmente con su red de apoyo primaria conformada por su madre, el padrastro (en proceso de divorcio), y un hermano menor de 14 años. Refiere que, si bien existe una relación estable entre los integrantes del hogar, el proceso de ruptura conyugal entre la madre y el padrastro ha generado un ambiente de tensión emocional y conflictos interpersonales. La comunicación se ha visto afectada, predominando en ocasiones el uso de gritos o formas inadecuadas de expresión emocional. El paciente identifica esta situación como un factor estresante que ha influido negativamente en su estado de ánimo, recordándole experiencias traumáticas del divorcio anterior de sus padres biológicos. Actualmente, se encuentra en un proceso de fortalecimiento de la comunicación asertiva y del cumplimiento de compromisos dentro del núcleo familiar.

Historia social

El paciente presenta buenas habilidades sociales y ha mantenido históricamente relaciones interpersonales adecuadas. Sin embargo, en el contexto del episodio depresivo actual, se observa una disminución del interés por actividades sociales y una tendencia a la apatía frente a espacios de interacción. A pesar de ello, conserva comunicación con sus redes de apoyo más cercanas, aunque de forma limitada. El retraimiento social y la reducción de la iniciativa para compartir con otros se asocian a los síntomas emocionales que manifiesta en el presente.

Historia socio-afectiva

A lo largo de su desarrollo, el paciente ha mostrado una adecuada capacidad para establecer vínculos afectivos significativos, tanto en el entorno familiar como en el social. Refleja una estructura de apego seguro con sus figuras parentales, quienes han sido constantes en el acompañamiento emocional. Sin embargo, se ha identificado una tendencia a la autoexigencia y al perfeccionismo como mecanismos de validación afectiva, lo que ha generado altos niveles de frustración ante la percepción de no cumplir con sus propias expectativas. En el contexto emocional actual, se observa una disminución en la expresión afectiva y en la capacidad para experimentar disfrute en las interacciones cotidianas, lo cual ha impactado negativamente su sentido de pertenencia y conexión emocional con los otros. A pesar de ello, mantiene una disposición positiva hacia el fortalecimiento de sus vínculos cercanos y reconoce la importancia del apoyo emocional recibido por parte de su familia.

Interconsultas e Intervenciones

Intervención psiquiátrica

No refiere

Intervención neurológica

No refiere

Intervención neuropsicológica

No refiere

Otras intervenciones

No refiere

EXAMEN MENTAL

Examen Mental

El paciente se encuentra orientado en las tres esferas con adecuada conciencia de sí mismo (autopsíquica) y del entorno (alopsíquica). Su presentación personal es acorde a su edad y contexto, con higiene y vestimenta apropiadas. Durante la entrevista se muestra receptivo, colaborador, atento a las indicaciones y con un nivel de lenguaje coherente y fluido.

Se observa un discurso organizado, sin presencia de ideas delirantes ni alteraciones del curso o forma del pensamiento. No se reportan ideas de muerte ni ideación suicida activa o pasiva al momento de la evaluación. No se evidencian alteraciones sensorio-perceptivas (alucinaciones o ilusiones). El contenido del pensamiento se encuentra centrado en preocupaciones académicas, con manifestaciones de autoexigencia, frustración frente al desempeño y sentimientos persistentes de desesperanza.

A nivel afectivo, se identifica una expresión emocional congruente con el discurso verbal, con ánimo depresivo de predominio disfórico. Refiere disminución del interés por actividades previamente placenteras, tendencia al aislamiento, y alteraciones en el patrón de sueño con insomnio de conciliación y somnolencia diurna compensatoria. Se conserva el juicio crítico, la introspección y la capacidad de insight sobre su malestar, con disposición favorable hacia el acompañamiento terapéutico.

Ciclos del Sueño

Alterados (Conducta de evitación pasiva a través del sueño, con posterior mejoría parcial del ánimo).

Apetito

Alterado

Actividades de Autocuidado

Independiente (Se observa una disminución en la iniciativa y en la autonomía para realizar actividades básicas de autocuidado).

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Impresión Diagnóstica (CIE 10 - DSM-V):

F321 - EPISODIO DEPRESIVO MODERADO

Establecido por primera vez

Si

PLAN DE INTERVENCIÓN

Plan de Intervención

Objetivo General

Reducir la sintomatología depresiva del paciente y favorecer su bienestar emocional, funcionalidad cotidiana y adaptación académica mediante intervenciones psicoterapéuticas centradas en la regulación emocional, fortalecimiento en la autonomía, y las habilidades de afrontamiento ante la dinámica familiar actual.

Objetivos Específicos

- Identificar y defusionar pensamientos asociados a autoexigencia, perfeccionismo y percepción de incapacidad.
- Promover la activación conductual mediante la reintroducción progresiva de actividades placenteras y significativas.
- Mejorar los hábitos de autocuidado, incluyendo sueño, alimentación e higiene personal.
- Desarrollar estrategias de regulación emocional y afrontamiento adaptativo del estrés académico.
- Fomentar la comunicación asertiva y el fortalecimiento del vínculo familiar como red de apoyo emocional.
- Disminuir el aislamiento social y facilitar la reintegración gradual a espacios académicos y recreativos.

Sugerencias e Interconsultas

Actualmente, no se considera necesaria la remisión a Psiquiatría, dado que el paciente ha mostrado una evolución clínica favorable, con reducción progresiva de la sintomatología depresiva y mejoría en su funcionalidad.

Sin embargo, se recomienda considerar interconsulta con el servicio de psiquiatría en caso de presentar una recaída significativa del estado anímico o agudización de los síntomas depresivos, especialmente durante la reanudación del semestre académico, dado que dicho contexto representa un factor potencial de estrés que podría afectar su estabilidad emocional.

Observaciones y Recomendaciones

Observaciones:

- El paciente ha mostrado una evolución favorable, con disminución progresiva de la sintomatología depresiva y mayor apertura a la participación activa en el proceso terapéutico.
- Se observa mayor conciencia emocional, mejora en la disposición para el autocuidado y avances en la reconexión con actividades significativas.
- Conserva un nivel adecuado de juicio crítico, insight y red de apoyo familiar funcional, lo cual actúa como factor protector.

Recomendaciones:

1. Continuar con el acompañamiento psicológico de forma regular, especialmente durante el reinicio del semestre académico, para prevenir recaídas y reforzar estrategias de afrontamiento. (1 vez por semana).
2. Mantener una rutina estructurada con las actividades de estudio, con los tiempos dedicados al proceso de aprendizaje y aplicación de estrategias identificadas para la recepción y avance.
3. Mantener una rutina estructurada de sueño, alimentación y actividades placenteras como medida de estabilización emocional.
4. Retomar la práctica de actividad física moderada y progresiva, de acuerdo con los intereses del paciente, como recurso de regulación emocional.
5. Promover espacios de comunicación familiar donde se refuercen el apoyo emocional y la expresión de necesidades de forma asertiva.
6. En caso de reaparición de síntomas depresivos de manera persistente o con mayor intensidad, considerar interconsulta con el servicio de psiquiatría para valoración integral.

DRA. MARIA ISABEL PUMAREJO

Psicóloga clínica
Tarjeta Profesional: 259542
Mag. TP3G - VIU